

INDICADO POR: Dr. Alexandre Marques			
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS			
RODINEI MASSETTI MOSNA			
IDADE: 63	PESO: 92	ALTURA: 1,75	PROFISSÃO: Engenheiro Elétrico.
SINTOMAS: Riscos punziados, suspensões punziadas.			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Glibenclamide			
MÉDICO: Dr. Alexandre Marques (Neuro)			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: sedentário.			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5	LANCHE: JANTAR: 19-20h
HORA QUE DORME: 23-1h		HORA QUE ACORDA: 6-7:30h.	
COCHILHO () S (X) N	DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: (X) S () N	/ DORMEM NO QUARTO: () S (X) N		PET NO QUARTO: () S (X) N
BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N Social			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 1x-2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: quebra		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III	IAH: 25 Sept	SPO2: 80% min.
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: (Pernas inquietas)			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA	(N) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
11/06/25 Avaliação Max. Swift for			
23/06 Retirada:			
25 Acorda - Toma Café - Cuida do país - Engenharia (computador) 7:30 às 20h			
Banho - 21h. / TV.			
Orienta sobre Hig. do Sono e Rotina exerc. físico sua			
21/07 P = 4.8 (med) / 5.5 (Perc)			
25 ZAH = 0.4 efw			
n. de uso: 1h2'			
fuga = 1.5 lpm.			
sua avaliação			

13d = 8d de uso

04/08
25

P = 4 - G cally
IAH = 0,4 efer
M. de uso: 4m
fuga = 1.7 epu.

Pede o diário do sono

Ana Cláudia

RODINEI MASSETTI MOSNA

IDADE:	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS:			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS:			
MÉDICO:			
MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO:			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:
HORA QUE DORME:	HORA QUE ACORDA:		
COCHILLO () S () N	DORME ACOMPANHADO: () S () N		
TEM FILHOS: () S () N	DORMEM NO QUARTO: () S () N	PET NO QUARTO: () S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () N	X NA SEMANA () N		
FUMO: () S () N	MACÓDIA () S () N	NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIROINTE:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH:	SPOT:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDOCRINA () CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA	() NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S () N	SPOT CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:	



neuralprime

À Dr Ana Cláudia (Fisioterapia especializada em sono)

Paciente RODINEI MASSETTI MOSNA portador de apneia do sono moderada e queixa cognitiva

Solicito avaliação para CPAP

Att

26/05/2025

Dr Ana Cláudia : 12 - 99724-7053

Dr. Alexandre C. Marques
Neurologista
CRM-SP 146146

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (25,5 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (92%);
3. Aumento da latência para o início do sono (42,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Diminuição da latência para o início do sono REM (40,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (83,0 %) (VN= $\geq$ 85%);
6. Aumento do índice de despertares (23,7 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (3,0 %) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (59,7 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (15,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (21,8 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco intenso, constante verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice aumentado (67,6 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
13. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

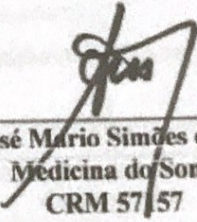
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado. Sugerir distúrbio de movimento. Presença de bruxismo.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57